SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

HƯỚNG DẪN

Áp dụng mô hình phân công chăm sóc người bệnh tại các khoa, bộ phận

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI

– Chọn mô hình phân công chăm sóc phù hợp cho từng khoa, bảo đảm mỗi người bệnh (NB) nội trú có một điều dưỡng/hộ sinh (ĐD/HS) chịu trách nhiệm chăm sóc chính trong mỗi ca và tiến tới suốt đợt điều trị.

– Làm căn cứ triển khai và minh chứng tiêu chí C6.3 (NB được chăm sóc toàn diện) và C6.1 (hệ thống quản lý điều dưỡng, bàn giao ISBAR).

– Áp dụng cho các khoa lâm sàng có giường, Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu - HSTC & Chống độc, PT-GMHS, Thận nhân tạo; các khoa cận lâm sàng áp dụng phần phân công theo vị trí (mục III.4).

II. CĂN CỨ

– Bài 2 “Các mô hình phân công chăm sóc”, sách “Quản lý Điều dưỡng trưởng khoa 2026”, Bộ Y tế, NXB Y học (Thư viện tài liệu 2026, mục 01).

– Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện (Cần xác minh điều khoản trích dẫn).

– Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, tiêu chí C6.1, C6.3 (phiên bản áp dụng 2026: Cần xác minh); hồ sơ C6.3 của Bệnh viện (QĐ-C6.3, SOP-C6.3-01).

– Số giường thực kê và nhân lực ĐD-KTY-HS theo dữ liệu NT Nursing (Thống kê giường bệnh các khoa; Danh sách ĐD-KTY-NHS chính thức T9/2026).

III. MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT CHO TỪNG KHOA

Nguyên tắc chung: không áp dụng mô hình theo nhiệm vụ thuần tuý cho NB nội trú. Khoa đủ điều kiện áp dụng chăm sóc toàn diện (5–7 NB/1 ĐD ca ngày theo tài liệu đào tạo); khoa chưa đủ áp dụng theo nhóm, mỗi nhóm có ĐD trưởng nhóm, và lập lộ trình tiến tới toàn diện. Mô hình theo nhiệm vụ chỉ dùng tạm khi cấp cứu hàng loạt hoặc thiếu nhân lực đột xuất, ĐDT khoa ghi lại lý do.

Ghi chú số liệu: “NB/ĐD ca ngày (ước tính)” = giường thực kê ÷ [(nhân lực − 1 ĐDT) × 50%], giả định khoảng một nửa nhân lực có mặt ca ngày sau trừ trực đêm, nghỉ bù, nghỉ phép. Nhân lực nguồn có thể gồm cả KTY. ĐDT khoa cần thay bằng số thực tế.

1. Khoa lâm sàng có giường nội trú

Khoa	Giường thực kê	Nhân lực	NB/ĐD ca ngày	Mô hình đề xuất	Cách tổ chức

			(ước tính)		
Nội Tổng quát	55	16	~7	Theo nhóm → toàn diện	2–3 nhóm theo dãy buồng; mỗi ĐD nhận 6–7 NB cố định từ vào đến ra viện; NB chăm sóc cấp I giao ĐD vững tay nghề.
Nhi	55	15	~8	Theo nhóm	2–3 nhóm theo buồng/nhóm tuổi; trưởng nhóm lập KHCS; hướng dẫn người nhà cùng chăm sóc (cho ăn, vệ sinh, theo dõi sốt) theo phân cấp.
Phụ Sản	40	20	~4	Toàn diện (mẹ – con)	1 HS/ĐD phụ trách cả sản phụ và trẻ sơ sinh của buồng mình; phòng sinh giữ phân công theo vị trí (đỡ đẻ, hồi sức sơ sinh).
Nội Tiêu hóa	25	8	~6	Toàn diện	2 ĐD ca ngày, mỗi người 1 dãy buồng; ĐDT kiêm trưởng nhóm, giám sát NB cấp I.
Truyền Nhiễm (Nội Nhiễm)	25	8	~6	Toàn diện	Như Nội Tiêu hóa; phân buồng theo đường lây, ĐD phụ trách buồng cách ly cố định trong ca để giảm lây chéo.
Ngoại Tổng quát	20	5	~10	Theo nhóm (1 nhóm)	Thiếu nhân lực cho toàn diện: ĐDT làm trưởng nhóm, ĐD chia NB theo buồng, hộ lý hỗ trợ chăm sóc cơ bản; đề xuất bổ sung nhân lực.
Ngoại Chấn thương	18	6	~9	Theo nhóm (1 nhóm)	Như Ngoại TQ; ưu tiên ĐD cố định cho NB sau mổ, bó bột, kéo tạ; cân nhắc ghép ca đêm liên khoa ngoại.
Cấp cứu - HSTC & Chống độc	12	11	~2–3	Toàn diện (hồi sức) + theo nhiệm vụ khi cấp cứu hàng loạt	Buồng hồi sức: 1 ĐD : 2–3 NB theo mức độ nặng; khu cấp cứu: phân vị trí (phân loại, hồi sức, thủ thuật) và chuyển ngay sang nhiệm vụ khi có thảm hoạ/cấp cứu hàng loạt.
YHCT - PHCN	Chưa có số	11	—	Theo nhóm	Nhóm ĐD + KTY PHCN cùng phụ trách một nhóm NB; ĐD phụ trách chăm sóc, KTY phụ trách tập luyện; thống nhất KHCS chung.
Liên Chuyên khoa (TMH, Mắt, RHM, Da liễu)	Chưa có số	17	—	Theo nhóm theo chuyên khoa	Mỗi chuyên khoa một nhóm; NB nội trú giao ĐD chăm sóc chính; phòng thủ thuật phân theo vị trí.

2. Khoa, bộ phận đặc thù

Khoa/bộ phận	**Mô hình đề xuất**	**Cách tổ chức**
PT - GMHS (5 giường hồi tỉnh, 12 NV)	Theo vị trí trong phòng mổ; toàn diện tại hồi tỉnh	Phòng mổ: dụng cụ viên, chạy ngoài, phụ mê theo ca mổ (bản chất nhiệm vụ, bắt buộc có bảng kiểm an toàn phẫu thuật). Hồi tỉnh: 1 ĐD : 2 NB, bàn giao ISBAR khi chuyển về khoa.
Thận nhân tạo (10 NV)	Toàn diện theo ca chạy thận	Mỗi ĐD phụ trách cố định một nhóm máy/NB trong suốt buổi lọc và theo dõi NB đó qua các buổi; số máy/ĐD theo quy định chuyên môn (Cần xác minh).
Khám bệnh (39 NV)	Theo vị trí, có người phụ trách NB trong lượt khám	NB lưu ngắn nên phân vị trí (đón tiếp – phân luồng, bàn khám, thủ thuật, tư vấn); ĐD bàn khám chịu trách nhiệm NB của bàn từ gọi số đến hoàn tất chỉ định; NB nặng có ĐD đưa đi và bàn giao.

3. Khoa cận lâm sàng và bộ phận hỗ trợ

Khoa Xét nghiệm, CĐHA - TDCN, Dược, KSNK, Tổ Tiêm chủng không phân công chăm sóc NB nội trú; áp dụng phân công theo vị trí công việc, nhưng phải có người chịu trách nhiệm NB trong thời gian NB ở khoa (tiếp nhận, nhận dạng NB ≥ 2 yếu tố, theo dõi, bàn giao lại khoa lâm sàng). Phòng Điều dưỡng (2 nhân sự) giữ vai trò hướng dẫn, giám sát, tổng hợp.

IV. NHIỆM VỤ

Người thực hiện	Nhiệm vụ
Điều dưỡng trưởng khoa	Chọn mô hình theo bảng mục III, trình Trưởng khoa; lập bảng phân công hằng ngày (mẫu BM-PCCS-01); điều chỉnh nhân lực giữa các nhóm; đi buồng cùng bác sĩ; kèm cặp ĐD còn yếu; báo cáo PĐD khi phải chuyển tạm sang mô hình theo nhiệm vụ.
ĐD trưởng nhóm	Lập và cập nhật kế hoạch chăm sóc cho NB trong nhóm; phân NB cho ĐD trong nhóm; giám sát, hỗ trợ; trao đổi với bác sĩ điều trị.
ĐD/HS chăm sóc chính	Nhận định, thực hiện chăm sóc theo phân cấp; tự giới thiệu tên với NB và người nhà; ghi phiếu chăm sóc; bàn giao ISBAR cuối ca; hướng dẫn người nhà cùng chăm sóc.
Hộ lý	Hỗ trợ chăm sóc cơ bản theo phân công của ĐD chăm sóc chính, không làm kỹ thuật chuyên môn.
Phòng Điều dưỡng	Hướng dẫn, tập huấn, giám sát hằng tháng; tổng hợp chỉ số; đề xuất bổ sung nhân lực cho khoa không đủ điều kiện.

V. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (đề xuất)

Thời gian	Nội dung	Kết quả
11/2026	Tập huấn Bài 2 cho ĐDT, ĐD trưởng nhóm; khoa chọn mô hình, gửi bảng phân công mẫu về PĐD	100% khoa có mô hình đăng ký
12/2026	Áp dụng thử tại Nội TQ, Phụ Sản, Nội TH, Truyền Nhiễm; các khoa khác áp dụng theo nhóm	Bảng phân công BM-PCCS-01 dán tại buồng/ghi HSBA
Quý I/2027	Giám sát bằng bảng kiểm BK-PCCS-01; sơ kết, điều chỉnh; mở rộng toàn diện sang Nhi, YHCT-PHCN nếu đủ nhân lực	Báo cáo sơ kết, đề xuất nhân lực khối ngoại
Từ quý II/2027	Duy trì, đưa chỉ số vào giám sát chất lượng điều dưỡng hằng tháng	Minh chứng C6.3

VI. CHỈ SỐ GIÁM SÁT

Chỉ số	Cách đo	Mục tiêu đề xuất
Tỷ lệ NB nội trú có ĐD chăm sóc chính ghi rõ trên bảng phân công	Số NB có tên ĐD phụ trách / tổng NB, kiểm tra ngẫu nhiên	≥ 95%
Tỷ lệ NB/người nhà biết tên ĐD chăm sóc mình	Phỏng vấn ngẫu nhiên 5 NB/khoa/tháng	≥ 80%
Tỷ lệ NB được giữ cùng ĐD chăm sóc chính ≥ 3 ngày liên tiếp (ca ngày)	Đối chiếu bảng phân công	≥ 70% (khoa toàn diện)
Tỷ lệ bàn giao ca đúng ISBAR	Bảng kiểm bàn giao C6.1	≥ 90%
Số lần chuyển tạm sang mô hình theo nhiệm vụ	Sổ ghi của ĐDT	Theo dõi, phân tích nguyên nhân

Mục tiêu là đề xuất của Phòng Điều dưỡng, cần Hội đồng Điều dưỡng thống nhất.

VII. BIỂU MẪU

BM-PCCS-01. Bảng phân công chăm sóc người bệnh (theo ca)

Khoa: …… Ngày: ……/……/20…… Ca: ☐ Sáng ☐ Chiều ☐ Đêm Mô hình: ☐ Toàn diện ☐ Theo nhóm ☐ Tạm theo nhiệm vụ (lý do: ……)

Nhóm	ĐD trưởng nhóm	ĐD/HS chăm sóc chính	Buồng/giường phụ trách	Số NB	NB cấp I	Hộ lý hỗ trợ	Ghi chú

Không ghi họ tên NB trên bảng dán tại buồng; chỉ ghi số buồng, số giường.

BK-PCCS-01. Bảng kiểm giám sát áp dụng mô hình phân công chăm sóc

TT	Nội dung kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	Khoa có mô hình phân công đã đăng ký với PĐD			
2	Bảng phân công ca hiện tại đầy đủ, đúng mẫu BM-PCCS-01			
3	Mỗi NB có 1 ĐD/HS chăm sóc chính được ghi tên			
4	Số NB/ĐD ca ngày phù hợp mô hình (toàn diện ≤ 7)			
5	NB cấp I được giao ĐD có kinh nghiệm			
6	ĐD trưởng nhóm có kế hoạch chăm sóc cập nhật cho NB trong nhóm			
7	Phỏng vấn NB/người nhà: biết tên ĐD chăm sóc			
8	Bàn giao ca theo ISBAR có ĐD chăm sóc chính tham gia			
9	ĐDT đi buồng cùng bác sĩ trong ngày			
10	Nếu chuyển tạm sang theo nhiệm vụ: có ghi lý do, báo PĐD			

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Hội đồng Điều dưỡng;
- ĐDT các khoa;
- Lưu: PĐD.

NGƯỜI SOẠN

CKIĐD. Võ Hồng Thái